

46 - 01-L'observation en neurologie - Pr. Kissani

(0:02 - 0:24)

Là, on va voir le premier cours de sémiologie neurologique, qui est l'observation en neurologie. Tout d'abord, il faut savoir que le système nerveux, il est complexe. Ça ne veut pas dire qu'il est difficile, mais juste, il faut bien maîtriser les notions de l'anatomie, de la physiologie, du fait du passage de différentes structures dans des espaces assez restreints.

(0:25 - 0:38)

Donc, ça veut dire que c'est complexe. Et par conséquent, la sémiologie va être aussi un peu complexe. Donc, il faut bien la maîtriser, bien lire et bien comprendre pour maîtriser les différents syndromes et pour maîtriser l'observation neurologique.

(0:38 - 0:58)

Sachez aussi que les seules cellules de l'organisme qui ne se multiplient pas sont les cellules nerveuses et musculaires et aussi le mélanocytes, à part une petite exception pour les cellules de l'hippocampe. Donc, ça veut dire que c'est vraiment très précieux. Il ne faut pas avoir ou faire des erreurs diagnostiques, parce que sinon, les dégâts et les séquelles risquent d'être très importantes.

(1:00 - 1:11)

Tout d'abord, l'observation neurologique comporte différents aspects, comme toute observation comme discipline médicale. Il y a l'interrogatoire ou l'anamnèse. Il y a l'examen clinique, général, neurologique, puis somatique.

(1:12 - 1:24)

Une conclusion clinique qui doit parler de syndrome et pas de symptômes. Le raisonnement, tout d'abord dire est-ce que c'est organique ou pas organique, selon qu'il y a ou non des signes physiques. La topographie de l'atteinte.

(1:24 - 1:34)

Le mécanisme. La topographie, c'est-à-dire quelle est la structure ou les structures qui peuvent expliquer ces troubles. Le mécanisme, c'est-à-dire par quel mécanisme arrivent ces troubles.

(1:35 - 1:46)

Vasculaire, infectieux, inflammatoire, compressible par le tumeur. Et les étiologies. Donc on commence l'interrogatoire par l'identité, l'âge, le sexe qui sont importants.

(1:47 - 1:59)

Il y a des pathologies plus fréquentes chez l'enfant, chez le sujet âgé. Le sexe, il y a des maladies héréditaires qui touchent le garçon, pas la fille. La profession, il y a par exemple les mineurs qui sont touchés par des maladies des mines.

(1:59 - 2:10)

L'origine, il y a certaines maladies régionales. Il y a la résidence, la fratrie, la latéralité. En sachant que l'hémisphère gauche et droit ne comportent pas la même structure.

(2:11 - 2:25)

Et là, il faut éviter le terme d'hémisphère majeur, mineur. Même l'hémisphère droit qui est majeur, qui est mineur pour le langage, il est majeur pour d'autres fonctions comme l'espace, la musique, etc. Après, on cherche les antécédents personnels, familiaux.

(2:25 - 2:33)

Cherchez les cas similaires, la consanguinité. Et là, vous avez un arbre généalogique. Vous voyez en noir les cas atteints et les cas non atteints.

(2:33 - 2:44)

Et là, ça veut dire que c'est une maladie qui est autosomique, dominante. Pourquoi autosomique ? Parce qu'il touche les garçons et les filles. Et pourquoi domine ? Parce qu'elle est verticale.

(2:44 - 2:54)

Donc, elle touche les grands-parents, la maman et ça se transmet à un garçon. Et aussi la consanguinité. Cherchez les habitudes toxiques.

(2:55 - 3:14)

Chiffrez le tabagisme en paquet à nez, l'héolisme, le cannabisme. Et bien sûr, là, on a des maladies liées au tabagisme comme les cardiopathies vasculaires, l'héolisme qui donne aussi des atteintes neurogènes périphériques et cérébelleuses, le cannabisme, certains AVC hémorragiques, l'épilepsie. Et aussi, le motif de constatation.

(3:14 - 3:22)

Qu'est-ce qui amène le patient à consulter ? Et après, vous passez à l'histoire. Et toujours là, il faut dater exactement. Il ne faut pas dire que ça remonte à 3 semaines, 4 semaines.

(3:22 - 3:34)

Parce que si on voit dans 2 mois, ça risque d'être complètement changé. Et voir le mode des différents signes fonctionnels. Après, passez à l'examen clinique, l'examen général.

(3:36 - 3:54)

L'abord général du patient. Donc, comment est le patient, sa conscience, son contact ? Est-ce qu'il y a un contact facile ? Par exemple, avec des patients schizophréniques, il ne peut y avoir aucun contact possible. Les constantes, la tension artérielle, la fréquence cardiaque, la température.

(3:55 - 4:05)

Après, on passe à l'examen neurologique. A l'examen neurologique, on commence par la motricité. Étudier la motricité, voir la marche, la station de boue, l'étude de Romberg.

(4:05 - 4:17)

Donc, Romberg demande au patient de fermer les yeux, les pieds joints. Et là, vous voyez, si c'est normal, il n'y a pas de problème. Si c'est négatif, avec des oscillations, le patient a l'impression qu'il trébuche en avant et en arrière, mais il ne tombe pas.

(4:18 - 4:30)

Ça fait plutôt atteinte cérébelleuse. Ou bien, si c'est positif, à ce moment-là, est-ce que c'est antérieur ou postérieur ? C'est ce qu'on appelle antérieur ou latéraux rétropulsion. Là, plutôt, c'est la sensibilité profonde.

(4:30 - 4:38)

Ou est-ce que c'est latéralisé ? Là, c'est plutôt vestibulaire. Après, on passe aux forces musculaires globales et segmentaires. Global, c'est par le barré.

(4:38 - 4:48)

Au moment supérieur, le patient tient les bras, coude en expansion. Après, le mangasini, il se met sur son dos. Les cultus dorsales.

(4:48 - 4:54)

Et là, il fléchit la cuisse à 90 degrés. Et le genou à 90 degrés sur les cuisses. Et on voit s'il tient bien.

(4:55 - 5:01)

Sinon, on dit qu'il y a une chute. Là, ça veut dire qu'il y a atteinte des forces globales. Après, les forces segmentaires.

(5:01 - 5:16)

Toujours comparativement. Après, on passe au tonus. Est-ce que c'est une hypotonie, comme

ce qu'on voit dans le cérébelleux ou les neuropathies périphériques ? Ou bien, est-ce que c'est une hypertonie ? Hypertonie est de type soit plastique ou extra-pyramidal.

(5:16 - 5:25)

Par exemple, c'est une hypertonie parkinsonienne avec une roudanté. Surtout au niveau des poignets. Ou bien élastique ou pyramidal.

(5:26 - 5:34)

Et là, c'est surtout les fléchisseurs des membres supérieurs. Et les extenseurs des membres inférieurs. Et ça, c'est, par exemple, quand vous avez une atteinte du faisceau pyramidal.

(5:34 - 5:41)

Après, vous passez aux réflexes. Ostéotendineux, cutané, myqueux. Là, vous avez le réflexe ostéotendineux.

(5:41 - 5:49)

L'exemple, par exemple, le bicipital gauche. Vous voyez, le patient, soit on percute directement le tendon du biceps. Et la réponse est qu'une flexion de l'avant-bras sur le bras.

(5:51 - 5:59)

Ou bien, vous mettez votre doigt sur le tendon. Là, vous avez aussi le réflexe tricipital. Percutez le tendon du tricep vers une extension de l'avant-bras.

(5:59 - 6:06)

Ou bien, du style radial. Vous percutez à côté de la silhouette radiale sur le tendon. Là, vous allez avoir une flexion aussi.

(6:06 - 6:13)

Ou bien, du cubitopronateur. On contacte la cellulite cubitale. Deux centimètres en proximale.

(6:13 - 6:21)

Et là, vous percutez les cubitaux. Et vous allez avoir une pronation de la main. Au membre inférieur, vous avez deux réflexes ostéotendineux.

(6:22 - 6:32)

Le rotulien qui explore la racine L3 et L4 au niveau du tendon du rotulien. Et là, vous avez une extension de la jambe sur la cuisse. Ou bien, l'achilien au niveau du tendon d'Achille.

(6:32 - 6:42)

Et pas d'Achille. Et là, vous allez avoir une plantiflexion qui explore la racine S1. Là, vous avez, comme en fait, on recherche le réflexe bicipital.

(6:42 - 6:48)

Il faut bien relâcher la patiente. Vous tenez sa main et vous percutez votre doigt. Vous avez une flexion de l'avant-bras.

(6:49 - 6:55)

Pour le réflexe cutaneo-muqueux. On commence par les cutaneos abdominaux. Donc, soit ils sont présents, normaux.

(6:55 - 7:00)

Soit ils sont abolis. Ce qu'on voit dans la teinte non-gène périphérique. Ou bien pyramidal.

(7:00 - 7:06)

Vous avez les cutaneos plantaires. Quand vous percutez. Par exemple, vous stimulez la plante du pied.

(7:06 - 7:12)

De bas et de dehors. Vers le haut et le dedans. Avec une pointe mousse.

(7:12 - 7:20)

Jamais le stylo ou la seringue jetable. Mais c'est les petites aiguilles des chemises. D'accord ? Ou bien, c'est la pointe du marteau.

(7:20 - 7:28)

Qu'il faut désinfecter après. Et normalement, si vous avez une extension des gros orteils. Et des 4 derniers orteils.

(7:28 - 7:33)

Avec une dorsiflexion majestueuse du gros orteil. C'est ce qu'on appelle le signe Wadinski. Qui signe la teinte pyramidal.

(7:34 - 7:42)

En sachant que 10% des syndromes pyramidal. Ne comportent pas du signe Wadinski. Et après, vous avez le réflexe muqueux.

(7:42 - 7:48)

Le réflexe moseilleux. Vous stimulez le fond de la gorge. Et là, vous avez une envie de vomir.

(7:48 - 7:53)

Ca explore le 9, la voie afférente. Et le 10, la voie efférente. Et le réflexe corneal.

(7:53 - 7:59)

Vous ouvrez les paupières du patient. Et vous prenez un coton stéré. Et vous touchez la cornée.

(7:59 - 8:04)

Très doucement au milieu. Et normalement, la réponse normale. C'est une fermeture de la paupière.

(8:05 - 8:11)

La voie afférente par le 5,1. Le nerf frontal. Et la voie efférente par le nerf facial.

(8:12 - 8:17)

Après, vous passez à l'examen de la sensibilité. Et là, vous avez les différents dermatomes. Sur cette image de droite.

(8:18 - 8:23)

Et après, vous explorez toutes les sensibilités. Tactile, fine, discriminative. Par exemple, vous prenez deux aiguilles.

(8:23 - 8:30)

Et le patient doit sentir à quelques millimètres. Au niveau de la paume de la main qui est très sensible. Et par exemple, jusqu'à 6 centimètres.

(8:30 - 8:36)

Il doit sentir une seule stimulation. Dans les zones les moins dotées en récepteurs. Comme par exemple au niveau des épaules ou des fesses.

(8:37 - 8:42)

Et après, vous cherchez aussi. Sensibilité thermique, algique. Profonde, vibratoire avec le diapason.

(8:42 - 8:49)

Et surtout, chercher dermatome par dermatome. Et là, vous allez avoir soit. Un problème de

perte totale de la sensibilité.

(8:50 - 8:55)

Une anesthésie. Il faut parler de quel territoire. Une hypoesthésie, une perte partielle.

(8:55 - 9:01)

Une hyperesthésie, c'est une exagération de la sensibilité. Ce qu'on voit parfois dans certains neurones. Et aussi, la localiser.

(9:02 - 9:06)

En dermatome. Soit radiculaire. Par exemple, c'est toute la racine.

(9:06 - 9:14)

Soit en distal tranquille. Et une fois que vous avez un niveau sensitif. Par exemple, vous avez le patient qui ne sent pas.

(9:14 - 9:18)

Au niveau des deux membres inférieurs. Jusqu'au niveau par exemple. C'est ce qu'on appelle.

(9:19 - 9:24)

Un niveau sensitif. Et là, ça vous signe l'atteinte médulaire. Et bien sûr, une atteinte médulaire.

(9:24 - 9:29)

Il faut toujours donner le niveau exact. Selon. Quel niveau vous avez.

(9:29 - 9:34)

Par exemple. C'est D4. C'est D6.

(9:35 - 9:41)

C'est D8, D10. Et ainsi de suite. Mais quand vous avez détruit la sensibilité de l'hémipore.

(9:41 - 9:45)

Là, il faut chercher. Au niveau de la cinquième percranienne. Est-ce qu'elle est contralatérale.

(9:46 - 9:52)

Par rapport au déficit de la sensibilité de l'hémipore. Là, vous avez une atteinte du transcérébral. Ce qu'on appelle un syndrome alterne-sensitif.

(9:53 - 9:57)

Ou bien. Est-ce qu'ils sont du même côté. Et là, l'atteinte est au-dessus du transcérébral.

(9:57 - 10:03)

Soit thalamique. Quand c'est proportionnel et pur. Ou bien.

(10:04 - 10:09)

Corticale. Quand elle est non proportionnelle. Et impure.

(10:09 - 10:14)

Ou bien impure quand elle est étendue. Et pourquoi est-ce qu'elle est pure dans le thalamus. C'est parce que toutes les sensibilités convergent.

(10:15 - 10:20)

Par la partie postérieure du thalamus. Et là, il n'y a aucune autre voie qui passe. Donc, être proportionnel, ça veut dire.

(10:20 - 10:27)

Que ça touche de la même manière la face. Le monde supérieur et le monde inférieur d'un côté. Et impure ou pur.

(10:27 - 10:32)

Pur, ça veut dire que ça ne touche que la sensibilité. Donc, c'est pour ça que dans le cortex. Elle est impure.

(10:32 - 10:38)

Et elle est proportionnelle quand elle est massive. Très étendue. Ou bien impure et non proportionnelle.

(10:38 - 10:44)

Quand elle est focalisée. Là, vous avez le cas par exemple. De l'atteinte médulaire jusqu'au cône terminal.

(10:45 - 10:49)

Mais en bas du col. Là, vous n'avez pas de moelle. Vous n'avez que les racines.

(10:49 - 10:55)

Ce qu'on va avoir, c'est un syndrome de la queue de cheval. Avec que des troubles. Bien sûr,

moteur et le paradis flasques.

(10:55 - 11:01)

Pas d'atteinte pyramidale. Et des troubles sensitifs qui n'incluent pas la racine L1. Qui sort au niveau du cône terminal.

(11:01 - 11:08)

Avec surtout de gros troubles sphinctériens. Incontinence anale, etc. Là, vous avez la schématisation.

(11:08 - 11:13)

De l'atteinte distale en chaussettes. Comme le cas par exemple. D'atteinte tronculaire au niveau des membres supérieurs.

(11:13 - 11:19)

En gants. Et l'atteinte radiculaire en bandes. Qui peut par exemple toucher tout un dermatome.

(11:19 - 11:25)

Au niveau d'un membre supérieur. Comme vous voyez ici. Au niveau de cette schématisation.

(11:28 - 11:35)

L'étude de la coordination. Tout d'abord dans le temps. Il faut chercher la vitesse du mouvement.

(11:35 - 11:39)

L'épreuve douanée. Comme ce que fait notre patient ici à droite. Il touche le doigt de l'examineur.

(11:39 - 11:45)

Et après il touche son nez. Et là on analyse ce mouvement là. Avec quelle vitesse il se fait.

(11:46 - 11:53)

Ça c'est l'inspection du médecin. Après soit dans l'espace. Ça sera soit une dysmétrie par l'épreuve douanée.

(11:54 - 11:58)

Membre supérieur. Ou bien l'épreuve talons genoux. Et là soit il dépasse la cible.

(11:58 - 12:04)

C'est ce qu'on appelle une hypermétrie. Il rate la cible c'est une dysmétrie. Il la dépasse c'est une hypermétrie.

(12:04 - 12:09)

Bien sûr vous imaginez que l'hypométrie. Quand il n'atteint pas il va être complété. Parce que le patient.

(12:10 - 12:15)

Qui n'a pas d'autres troubles que cérébelleux. Il sait qu'il n'a pas encore touché son nez. Ou son genou.

(12:15 - 12:21)

Et bien sûr sachez que la coordination. On peut toucher d'autres structures comme la parole. Qui a aussi besoin d'une bonne coordination.

(12:22 - 12:28)

C'est ce qui donne une dysarthrie cérébelleuse. La dysarthrie cérébelleuse. C'est une voie qui est explosive.

(12:29 - 12:34)

Scondée. Quand quelqu'un qui a consommé de l'alcool. Et même dans l'écriture.

(12:34 - 12:40)

Vous allez avoir des troubles de l'écriture. Donc toujours ne pas oublier de donner un pass sur une feuille. Un stylo pour qu'il écrive.

(12:40 - 12:48)

Et ça ça va aussi vous donner des données précises. Sur l'atteinte cérébelleuse. Après vous passez à l'examen des nerfs crâniens.

(12:48 - 12:52)

Le nerf olfactif. Première paire. Le nerf optique à deuxième paire.

(12:52 - 12:59)

Le nerf oculomoteur. Troisième, quatrième qu'on va voir en détail. Donc le nerf trijumeaux.

(12:59 - 13:04)

La sensibilité de la face. Et même la motricité des trijumeaux. Le nerf facial aussi qu'on va voir

en détail.

(13:05 - 13:10)

Septième paire crânien. Le cochléo vestibulaire c'est un nerf cochléaire pour l'audition. Un vestibulaire pour l'équilibration.

(13:11 - 13:15)

Ce qui va donner comme on a vu tout à l'heure. Un syndrome bilatéralisé. Et là ça dépend.

(13:15 - 13:22)

Vous allez avoir un syndrome vestibulaire soit harmonieux. Soit désharmonieux. Ça on va le voir dans le cours du trouble de l'équilibre.

(13:22 - 13:28)

Et après vous allez étudier le nerf glossopharyngeal. Ou la navette percrânienne. Que vous voyez ici.

(13:29 - 13:35)

Et après. Donc c'est le nerf de tout ce qui est. Sensibilité du pharynx, motricité.

(13:36 - 13:41)

Du pharynx etc. Et aussi une partie de la langue. Et le goût du tir postérieur.

(13:42 - 13:46)

Et le nerf vague. C'est le nerf pneumogastrique. Donc tout ce qui est végétatif parasympathique.

(13:46 - 13:53)

Et aussi les. Les cordes vocales aussi. Donc on peut avoir une aphonie.

(13:54 - 14:00)

Et le nerf spinal. C'est le nerf de sternocleidomastomidien et du trapèze. Et après en dernier.

(14:00 - 14:04)

Le nerf courant hypogloss. Ou la deuxième percrânienne. Tout ce qui est motricité de la langue.

(14:05 - 14:11)

Le nerf olfactif. C'est la première percrânienne. C'est un nerf qui est.

(14:11 - 14:16)

Parmi les plus anciens nerfs. Embryologiquement. Formé.

(14:16 - 14:23)

Et il s'occupe de l'olfaction. Et toujours pour l'explorer. Il faut explorer narine par narine.

(14:23 - 14:28)

Et c'est un nerf qui est souvent. Endommagé dans les traumatismes. Surtout de la base du crâne.

(14:28 - 14:34)

Comme on le voit sur le schéma. Les fibres du nerf. Elles traversent la lame criblée de l'ethmoïde.

(14:36 - 14:41)

Pour le nerf optique. C'est la deuxième percrânienne. C'est un nerf déjà embryologiquement.

(14:42 - 14:46)

Surtout au niveau de la rétine. Qui a la même constitution. Que le cortex cérébral.

(14:47 - 14:52)

Et c'est le nerf de la vision. Donc sa principale fonction. C'est la vision avec les champs visuels.

(14:53 - 14:59)

Qu'on a surtout que l'être humain. Il a une vision frontale. On a les deux yeux qui sont dans un plan parallèle.

(14:59 - 15:05)

Dans le même plan. C'est pas comme d'autres animaux. Comme les oiseaux qui ont une vision latérale.

(15:05 - 15:10)

Chaque queue est dans une partie. Ou bien les caméléons qui ont une vision panoramique. C'est à dire les deux yeux.

(15:11 - 15:19)

Ils peuvent pratiquement balayer tout le champ. C'est à dire à presque 360 degrés. Les nerfs oculomoteurs.

(15:19 - 15:27)

C'est la troisième percrânienne. C'est à dire le nerf oculomoteur qu'on a. Qui assure tout ce qui est abduction de l'oeil. C'est à dire vers le dedans.

(15:28 - 15:33)

Abaissement, élévation. Bien sûr il y a le petit oblique. C'est à dire l'élévation et l'abduction de l'oeil.

(15:34 - 15:40)

Et aussi le releveur de la paupière. Il est aussi responsable. Du réflexe de l'accommodation.

(15:41 - 15:46)

Et du réflexe photomoteur. Donc grâce à ses fibres pupillaires. La contraction pupillaire.

(15:46 - 15:53)

Et donc on peut l'étudier par le réflexe photomoteur. Le réflexe, le nerf pathétique. C'est la quatrième percrânienne.

(15:54 - 16:00)

Il prend en charge uniquement un semuse. Qui est le grand oblique. Qui est responsable de l'abaissement et l'abduction.

(16:01 - 16:09)

Et le nerf oculomoteur externe. C'est le nerf responsable de l'abduction de l'oeil. Donc il énerve le droit externe.

(16:09 - 16:17)

Et donc c'est lui qui emmène l'oeil vers la latérale. Donc là vous voyez pour la troisième percrânienne. Regardez par exemple le petit enfant.

(16:18 - 16:24)

Il a un strabisme divergent de l'oeil gauche. Et regardez par exemple. Au niveau de l'autre photo.

(16:25 - 16:31)

Là vous avez un problème de ptosis. Et surtout. Donc regardez par exemple.

(16:31 - 16:36)

Là il n'arrive pas. L'enfant au niveau de son oeil droit. Il n'arrive pas à faire l'élévation.

(16:37 - 16:43)

De l'oeil au niveau de l'image. La deuxième en haut et à gauche. Et à droite, en bas et à droite.

(16:43 - 16:48)

Donc la deuxième image. Donc il n'arrive pas à faire l'abaissement. Alors qu'il le fait de l'oeil gauche.

(16:48 - 16:53)

Donc il a un problème d'atteindre la troisième percrânienne. Du côté droit. L'image en bas et à droite.

(16:54 - 16:59)

C'est la paralysie du nerf pathétique. Ou le nerf. La quatrième percrânienne.

(16:59 - 17:04)

Et vous voyez c'est le déficit. Donc l'abaissement, l'abduction de l'oeil. Qui n'arrive pas à se faire.

(17:04 - 17:11)

Et l'enfant souvent il a une attitude anormale. Par exemple pour voir en bas. Et en bas et à gauche c'est la paralysie du droit externe.

(17:12 - 17:18)

Ou de la sixième percrânienne. Et vous voyez donc il y a déjà. Un strabisme convergent de l'oeil droit.

(17:18 - 17:24)

Regardez au niveau de l'oeil droit. C'est à dire vous demandez au patient de voir droit. De vous voir droit dans le visage.

(17:24 - 17:28)

Et là son oeil droit. Il part en dedans. Ce qu'on appelle un strabisme convergent.

(17:28 - 17:35)

Donc il n'arrive plus à faire l'abduction de l'oeil. Pour la cinquième percrânienne. Le nerf trijumeaux.

(17:35 - 17:42)

C'est un nerf sensitif de la face principalement. Il énerve les trois parties. Pour le frontal.

(17:43 - 17:50)

Qui est le 5 1. C'est toute la partie au dessus de la paupière inférieure. Jusqu'au front. Et la partie interne du nez.

(17:50 - 17:57)

Pour le sous-orbitaire. Ou le 5 2. Il énerve la partie au dessous de la paupière supérieure. Jusqu'à la paupière inférieure.

(17:57 - 18:03)

Jusqu'à la lèvre supérieure. Et le nerf temporobuccal. Ou le nerf mondibulaire.

(18:05 - 18:12)

Ou le 5 3. Il énerve toute la partie inférieure. Et donc vous voyez que pratiquement c'est toute la moitié de la face. Sauf la cochette macélerine.

(18:13 - 18:19)

Et il y a la zone de rame séante. Au niveau de l'oreille. Qui est prise par le 7. Et vous voyez aussi au niveau de la face interne.

(18:19 - 18:24)

Sur le schéma à droite. Donc ça c'est sur le plan sensitif. Il est aussi moteur pour les nerfs.

(18:25 - 18:30)

Pour les macétères. Et les autres muscles pterygoïdiens. Donc il assure tous les mouvements.

(18:31 - 18:36)

Des mâchoires, de l'arrastication. Et aussi les sensoriels. Pour le muscle du marteau.

(18:37 - 18:43)

Donc il intervient dans l'audition. Et il est aussi végétatif. Lacrimal pour les glandes salivaires.

(18:44 - 18:48)

Pour le nerf facial. Donc c'est le nerf de la motricité. Principalement de la face.

(18:49 - 18:54)

Bien sûr ça commence depuis le front. Toute la face. Et même les muscles possédus.

(18:54 - 18:59)

C'est aussi un nerf mixte. D'ailleurs il est aussi responsable de la sensibilité. De la zone de rampe séante.

(19:00 - 19:07)

Au niveau du conduit auditif externe. Utragus, antitragus. Et aussi c'est un nerf qui est sensoriel.

(19:07 - 19:13)

Par l'innervation du muscle de l'étrier. Et donc dans cette paralysie. On peut avoir des hyperacousidous.

(19:13 - 19:18)

Douleuruses. C'est à dire que c'est le nerf qui freine. La pénétration de l'étrier.

(19:18 - 19:24)

Au niveau de l'oreille interne. Dès qu'il est paralysé vous allez avoir. Une transmission un peu forcée.

(19:24 - 19:31)

De l'onde sonore. Et donc ça donne des bruits très insupportables. Il a aussi en fait une fonction.

(19:31 - 19:36)

Végétative. Donc c'est essentiellement. Les glandes salivaires.

(19:38 - 19:43)

Et donc. C'est un nerf qui est mixte. Le nerf cochléo vestibulaire.

(19:43 - 19:48)

C'est la 8ème paire crânienne. Il est responsable. De l'audition par le nerf cochléaire.

(19:48 - 19:53)

Et de l'équilibration par le nerf vestibulaire. Et donc on peut étudier. Chaque contingent à part.

(19:54 - 19:58)

Le nerf glossopharyngien. C'est la 9ème paire crânienne. C'est un nerf mixte.

(19:58 - 20:04)

Donc essentiellement moteur pour le voile. Mais aussi sensitif pour toute la partie interne. Du pharynx.

(20:05 - 20:11)

Tout le pharynx en fait. Et même les deux tiers postérieurs de la langue. Et aussi sensoriel.

(20:11 - 20:16)

Pour le tiers postérieur de la langue en fait. Et aussi un nerf végétatif. Pour la glande parotide.

(20:17 - 20:23)

Le nerf vague. C'est la 10ème paire crânienne. Donc c'est un nerf essentiellement végétatif.

(20:23 - 20:29)

D'ailleurs on l'appelle le nerf glossopneumogastrique. Il énerve pratiquement tous les viscères. A l'intérieur de la cage thoracique.

(20:30 - 20:35)

Et même de l'épée. Périnée et de l'abdomen. C'est aussi un nerf moteur.

(20:36 - 20:40)

Qui énerve les muscles. Du voile du palais. Certains muscles constricteurs du pharynx et du larynx.

(20:40 - 20:46)

Il assure aussi la transmission. De la sensibilité somatique du pharynx. Du larynx et de l'épiglotte.

(20:46 - 20:51)

Ainsi qu'une partie des informations gustatives. Donc en fait. Au niveau de l'innervation du larynx.

(20:51 - 20:58)

Il y a les cordes vocales. Et on peut avoir par exemple le problème de voix bitonale. Et même phonique carrément.

(20:58 - 21:05)

Par paralysie de la 10ème paire crânienne. Et après en fait. Vous allez voir aussi le nerf

coquilleux.

(21:05 - 21:09)

Le glossopharyngeen. Le nerf vague. Tout ce qui est parasympathique.

(21:09 - 21:16)

Et là on arrive maintenant au nerf spinal qui énerve les trapèzes. Et le sternocleidomastoidien. Vous demandez au patient de soulever ses épaules.

(21:16 - 21:21)

De tourner la tête à droite à gauche. Afin de se nerver. Et en dernier lieu vous avez le nerf grand hypogloss.

(21:22 - 21:27)

Qui est la 12ème paire crânienne. Qui énerve les 12 muscles. Parce qu'il y a 13 muscles dans la langue.

(21:28 - 21:33)

Par le géniogloss. Tous énervés par le grand hypogloss. Vous allez avoir une paralysie de la langue.

(21:33 - 21:38)

Qui va être différente. C'est en rétraction ou protraction. Et aussi vous allez avoir une amyotrophie.

(21:38 - 21:45)

Vu que c'est un déficit qui est périphérique. Et après vous passez à l'étude des fonctions supérieures. Qui sont la conscience.

(21:45 - 21:56)

Le patient est-ce qu'il est conscient ? Est-ce qu'il est obnubilé ? Est-ce qu'il est somnolent ? Est-ce qu'il est confus ? Ou est-ce qu'il est comateux ? Et vous avez le chef de Glasgow pour apprécier ça. De 3 à 15. Vous avez l'attention.

(21:56 - 22:05)

Est-ce que le patient est concentré ? Par exemple il y a des enfants. Qui sont complètement altérés sur le plan de l'attention. Ils ne captent rien.

(22:05 - 22:14)

Parce que leur cerveau ne signe sur rien. C'est une maladie pour laquelle il y a un traitement actuellement. Après vous passez à l'orientation temporo-spatiale.

(22:14 - 22:22)

Dans le temps et dans l'espace. Par exemple qui est altéré dans la confusion mentale. Quelqu'un qui a été intoxiqué par le monoxyde carbone.

(22:22 - 22:26)

Ou par le méthane. Ou autre chose. Il va être perdu dans le temps et dans l'espace.

(22:27 - 22:33)

Et là vous allez avoir la mémoire. Il y a différents types de mémoire. La mémoire immédiate, la mémoire à court terme.

(22:34 - 22:39)

Qui est altérée dans l'Alzheimer par exemple. Le patient vous lui donne des consignes. Quelques secondes ou une minute à deux.

(22:40 - 22:44)

Et là il perd toutes ses consignes. Il ne se rappelle de rien. Ce qu'on appelle la perte de la mémoire de travail.

(22:44 - 22:51)

Qui est le premier symptôme qui apparaît dans la maladie d'Alzheimer. Après vous avez le langage. Il y a soit le langage parlé.

(22:51 - 22:56)

Le langage lu. Ou bien il y a la lecture. Il y a aussi l'écriture.

(22:57 - 23:09)

Et donc tout ça c'est le... Donc tout ceci c'est des choses qu'il faut bien connaître. Après il y a le jugement. Après vous avez les praxis.

(23:10 - 23:36)

Praxis c'est les fonctions élaborées de la motricité. Donc le patient il n'arrive pas à faire des gestes répétés par exemple. Il fait un geste simple comme le salame.

Il n'arrive pas par exemple à allumer une bougie ou à ouvrir une clé avec une serrure. Ouvrir une porte avec une serrure. Il y a aussi l'hypnose.

C'est les fonctions spécialisées de la sensibilité. Par exemple le patient vous lui donne une pièce de monnaie. Il vous dit que c'est arrondi.

(23:37 - 24:16)

C'est rugueux. Mais il n'arrive pas à interpréter ça comme pièce de monnaie. Les langages.

Là vous avez les deux aires principales. Bien sûr il y a d'autres aires qui interviennent. Il y a même actuellement le cerveau qui intervient.

Le thalamus aussi. Et ce qu'il faut retenir c'est qu'il y a l'aire de Broca qui est responsable de tout ce qui est articulation du langage. Donc par exemple quand on naît un mot, quand on fabrique un mot, c'est surtout l'aire de Broca qui articule ce mot.

Et de l'autre côté pour recevoir un mot, par exemple quelqu'un qui vous parle, pour décoder, c'est l'aire de Wernicke qui fait ça. Et donc normalement quand vous avez une atteinte de l'aire de Broca, vous avez une aphasie de Broca ou une aphasie motrice. Surtout des problèmes d'articulation.

(24:16 - 24:49)

Le problème, il va avoir des difficultés à prononcer. Par exemple, il va dire il prononce quelques mots ou bien l'aphasie de Wernicke, ce qu'on appelle une jargonaphasie. Le patient par exemple il parle, oui moi je suis là je suis ... comme ça.

Donc c'est en fait comme du néologisme, on ne comprend même pas ce qu'il dit. Et là vous avez entre les deux ce qu'on appelle le faisceau arché qui connecte et quand il est touché, vous allez avoir une aphasie de conduction. Le patient n'a ni problème d'articulation ni de compréhension de décodage mais c'est un problème de répétition.

(24:50 - 25:06)

Tout est normal, sauf quand vous demandez de répéter un mot, il n'arrive pas. Après vous faites bien sûr, après l'examen neurologique, sachez que les troubles neurologiques ils peuvent avoir des conséquences sur les articulations sur beaucoup d'autres choses. Il peut y avoir des escalas, etc.

(25:06 - 27:21)

Donc ce qu'il fait, il faut faire un examen général ou bien une maladie par exemple une tuberculose pulmonaire peut avoir des conséquences après sur le système nerveux. Une tuberculose peut passer du poumon vers les méninges ou le cerveau. Donc si vous ne cherchez pas, vous risquez de passer à côté de cette origine de la maladie.

Ou bien quelqu'un qui a une tumeur testiculaire il peut faire une métastase cérébrale. Donc si vous n'examinez pas le scrotum et les testicules du patient, vous risquez de passer à côté.

Après la conclusion clinique il faut rapporter des informations pertinentes et concises ne parler que de syndrome et jamais de symptômes.

Et après soit vous dites est-ce que c'est organique ou pas organique mécanisme donc topographique est-ce que c'est périphérique, est-ce que c'est central le mécanisme, c'est-à-dire par quel moyen vous avez l'atteinte est-ce que c'est vasculaire quand c'est aigu par exemple ça peut être une hémorragie ou une ischémie est-ce que c'est subaigu par exemple vous avez un problème infectieux, une tuberculose, etc. D'accord ? Ou bien après est-ce que c'est progressif là vous allez avoir un problème par exemple de processus occupant, ça peut être un méningiome ou bien est-ce que c'est insidieux à ce moment-là ça pourrait être dégénératif D'accord ? Et après bien sûr ceci va permettre de demander le minimum d'examens complémentaires et de ne pas bien sûr surdemander les examens et après là vous allez confirmer votre maladie et surtout prendre en charge votre patient et après bien sûr là il faut expliquer au patient ses troubles et prendre soit un schéma soit une maquette soit par exemple des clichés, ou là vous avez YouTube maintenant, ça dépend du niveau intellectuel du patient, ou bien vous pouvez expliquer un peu de façon banale, par exemple pour l'épilepsie vous pouvez comme un coupe-circuit pour le patient, etc. D'accord ? Donc tout ceci, c'est des choses qu'il faut bien retenir afin de mener une bonne observation clinique